

プライマリ・ケアの基盤と臨床像

プライマリ・ケアの範囲

- 未分化症状、予防、慢性疾患
- 単位は疾患でなく一人の人間
- 縦断観察が診断確率を変える
- 慣れを油断に変えない
- 家族、仕事、地域、変化するリスク
- 治療効果を明らかにし予防を可能に

臨床介入としての継続性

- 関係的継続性：反復診療
- 情動的継続性：記録を越えた物語
- 管理的継続性：計画の整合
- 固有の基準が微細な低下を示す
- 追跡が確実なら時間が不確実性を減らす
- 危険：固定、正常化、境界の弱化
- 定期的な診断リセット
- 単発値でなく軌跡として解釈

生物学的・社会的システム

- 疾患、病い、社会的病者状態
- 症状は組織、脳、感情、状況から
- 社会的決定要因が曝露と能力を形作る
- 差別と排除はストレスと剥奪を介す
- 反比例ケアの法則
- 「本物」と「心理的」に分けない
- 払えず届かない計画は無効

頻度の高い症状のパターン

- 疲労：多様な原因と段階的戦略
- 説明し切れない持続症状
- 大半は良性、時に重大疾患
- 精神疾患と身体疾患の共存
- 肯定的な病態説明とリハビリ目標
- 検査反復は恐怖と医源性害を増す
- 警告徴候は特異度が低く組合せで解釈
- 心理化も感情機序の無視も避ける

遅延を放置にしない経過観察

- 予定再診を伴う能動的管理
- 低確率で追跡が確実なら適切
- 急速悪化や再受診不能なら危険
- 継続性には好奇心、アクセス、説明責任
- 作業診断、警告徴候、症状緩和

多疾患併存

- 指標疾患を前提としない共存
- 一致する疾患と不一致疾患
- 治療は相乗的、中立的、拮抗的
- 危険、負担、目標、利益までの時間で優先
- 共通原因、トレードオフ、負担、競合リスク
- 指針の単純加算は実行不能
- 年齢による否定でなく個別化

慢性疾患の軌跡と適応

- 安定、進行、再発寛解、発作性
- 再燃ごとに別の可能性を検証
- 自己管理能力は変動する
- 適応が低下を隠す
- 反応変化が生活の質評価を変える
- 非遵守とせず作業量を減らす
- 具体的作業を尋ね以前と比較

生涯にわたる予防

- 原始予防：リスクを作る条件を変える
- 一次予防：発症を減らす
- 二次予防：無症候疾患を検出
- 三次予防：合併症を抑える
- 四次予防：不要な医療の害を減らす
- 治療閾値は絶対リスク、害、選好を統合
- 疾患を道徳的失敗としない
- 基礎リスクが高いほど絶対利益大
- 治療害と競合死亡が相殺

家族と地域の状況

- 家族歴：遺伝と共有環境リスク
- 同居者は食事、感染、安全に影響
- 地域疫学が確率を変える
- 商業的決定要因が曝露を形作る
- ヘルスリテラシーは関係的
- 守秘と個人の自律を守る
- 集積を察知し公衆衛生活動へ
- 規制、課税、安全な初期設定
- 平易な言葉、ティーチバック、通訳